



Résumé : Recommandations Formalisées d'Experts SFAR sur l'organisation de la prise en charge anesthésique en hospitalisation ambulatoire (sortie le jour même, sans nuit d'hébergement), structurées en 11 questions : définitions, critères d'éligibilité, information du patient, choix de la technique d'anesthésie, prise en charge des suites opératoires (douleur, prévention thromboembolique, NVPO), procédure de sortie, coordination et continuité des soins, évaluation et gestion des risques, spécificités liées à l'âge (pédiatrie, gériatrie), spécificités organisationnelles et spatiales, et responsabilité de l'anesthésiste-réanimateur. **71 recommandations au total.**

Méthodologie

Ce texte ne comporte **aucune grille de cotation scientifique imprimée** (pas de GRADE, pas de niveau de preuve, pas d'accord RAND/UCLA) — la force de chaque recommandation est encodée uniquement par le verbe modal qui l'introduit. Cette fiche reproduit cette convention telle quelle, par un chip déduit directement et exhaustivement du verbe modal de chaque énoncé (voir légende ci-dessous) — aucun grade GRADE n'est inventé pour ce document qui n'en emploie aucun.

R

S

P

N

Force (déduite du verbe modal de la source, aucune grille de cotation imprimée) — **R** = « il est recommandé » (forte) ; **S** = « il est souhaitable » (intermédiaire) ; **P** = « il est possible » (permissif/optionnel) ; **N** = « il n'est pas recommandé » (négatif).

Question 1 — Définitions

La prise en charge anesthésique en hospitalisation ambulatoire est un concept d'organisation centré sur le patient, avec sortie le jour même sans nuit d'hébergement, quel que soit l'acte (chirurgical ou médical, diagnostique ou thérapeutique) réalisé dans les conditions de sécurité d'un bloc opératoire.

Recommandation	Force
1. Il est recommandé de privilégier le mode de prise en charge ambulatoire des patients dès que les conditions de sa réalisation sont réunies.	R
2. Il est recommandé que seuls les acteurs d'une même structure définissent entre eux la liste des actes ambulatoires adaptés à leur expertise et à l'organisation mise en place, liste évolutive ; décision médicale prise en colloque singulier avec le patient.	R
3. Il est souhaitable qu'il n'y ait pas de liste réglementaire d'actes à réaliser en ambulatoire.	S

Question 2 — Critères d'éligibilité à l'hospitalisation ambulatoire

Concept fondamental : le triptyque acte-patient-structure (analyse du bénéfice/risque, prévisibilité de la prise en charge, organisation en place).

Recommandation	Force
4. Il est recommandé que l'éligibilité à l'ambulatoire repose sur l'analyse du bénéfice/risque pour le patient, la prévisibilité de sa prise en charge et de l'organisation mise en place, en particulier la permanence et la continuité des soins.	R
5. Il est recommandé que la sélection des actes réalisés en ambulatoire soit fondée sur la maîtrise des risques, de la durée et des suites de ces actes.	R
6. Il est possible d'intégrer certains actes urgents dans un programme ambulatoire, à condition de ne pas perturber le fonctionnement de l'unité et de garantir le même niveau de qualité et de sécurité au patient.	P
7. Il est recommandé que les patients de statut ASA I, II et III stable soient éligibles à l'ambulatoire, sur analyse du rapport bénéfice/risque au cas par cas.	R
8. Il est recommandé d'assurer les conditions de la compréhension et de l'acceptation des modalités de prise en charge par le patient : traducteur pour les patients non francophones, accompagnement des mineurs par un parent/représentant légal, accompagnement des patients à trouble du jugement par un tiers garant du jeûne/observance/continuité des soins.	R
9. Il est recommandé de s'informer auprès du patient que le lieu de résidence postopératoire est compatible avec la prise en charge ambulatoire — la durée du transport et la distance ne sont pas des facteurs d'exclusion.	R
10. Il est recommandé de formaliser une convention entre établissements afin de prévoir la prise en charge d'une complication éventuelle par un établissement autre que celui de l'acte ambulatoire.	R



Recommandation	Force
11. Il est recommandé de s'assurer que lors du trajet de retour le patient ne conduise pas un véhicule et qu'il soit accompagné par un tiers.	R
12. Il est recommandé que la présence d'un accompagnant au lieu de résidence postopératoire soit évaluée en fonction du couple acte-patient et définie au préalable par les acteurs de la structure.	R

Question 3 — Modalités de l'information du patient

Le patient hospitalisé en ambulatoire est acteur de sa préparation préopératoire et de sa réhabilitation postopératoire au lieu de résidence.

Recommandation	Force
13. Il est recommandé de délivrer une information précoce et réitérée à chaque étape de la prise en charge.	R
14. Il est recommandé que l'information donnée au patient soit élaborée et concertée entre les différents acteurs amenés à en délivrer tout ou partie.	R
15. Il est recommandé que la consultation préanesthésique soit réalisée par un anesthésiste-réanimateur connaissant les modalités de fonctionnement de la structure ambulatoire.	R
16. Il est recommandé, au cours de la consultation pré-anesthésique, de dispenser une information adaptée sur : le jeûne et la gestion des traitements, les exigences des techniques d'anesthésie, les conditions de sortie et l'accompagnement nécessaire, les consignes postopératoires, les méthodes d'analgésie, les recours en cas d'événement imprévu, l'accès à une information complémentaire.	R
17. Il est recommandé d'informer le patient des effets de l'anesthésie/sédation sur les fonctions cognitives et la vigilance pendant les 12 premières heures, avec variabilité interindividuelle de ces effets et de leur durée.	R
18. Il est recommandé d'informer le patient que la conduite de tout véhicule est proscrite pendant les 12 premières heures du fait de l'anesthésie ; la reprise devra tenir compte du handicap lié à l'acte.	R
19. Il est recommandé d'informer le patient pratiquant la conduite de groupe lourd ou de machine à haut niveau attentionnel que des troubles de la vigilance peuvent persister pendant quelques jours.	R
20. Il est recommandé d'informer les patients des effets secondaires possibles du traitement péri-opératoire (anxiolytique, antalgiques majeurs) sur les fonctions cognitives et la vigilance.	R
21. Il est recommandé de ne pas dispenser d'information au patient pendant la phase de récupération de l'anesthésie, du fait d'une possible altération de la mémoire et de sa consolidation.	R
22. Il est recommandé que l'information délivrée soit orale, complétée par un support écrit court et lisible ou audiovisuel, incitant le patient à poser toute question utile, avec traçabilité.	R
23. Il est possible de faire signer au patient le document rappelant les exigences de prise en charge ambulatoire (vertu pédagogique) — cette signature n'engage pas la responsabilité juridique du patient et ne défausse pas celle du médecin.	P
24. Il est recommandé de pouvoir établir un contact avec le patient dans les jours précédant l'hospitalisation pour réitérer les consignes, en particulier en cas de consultation délocalisée ou d'acte itératif.	R

Question 4 — Choix de la technique d'anesthésie

Le choix de la technique repose sur l'analyse du bénéfice/risque pour le patient, l'acte réalisé et l'organisation mise en place.

Recommandation	Force
25. Il est souhaitable de formaliser les modalités de réalisation de la visite préanesthésique et d'en assurer la traçabilité.	S
26. Il est possible de prescrire une prémédication anxiolytique et/ou analgésique.	P
27. Il est recommandé d'établir des règles de jeûne préopératoire adaptées à la programmation opératoire pour améliorer le confort du patient.	R



Recommandation	Force
28. Il n'est pas recommandé de stratégie spécifique à la prise en charge anesthésique ambulatoire — l'ensemble des agents (hypnotiques, morphiniques, curares) peut être utilisé, en privilégiant si possible les agents à durée de vie courte et effets secondaires réduits.	N
29. Il est souhaitable d'adapter la technique de rachianesthésie à la nécessité d'une reprise rapide de l'autonomie (faibles doses, adjuvants liposolubles, latéralisation).	S
30. Il est recommandé de réaliser des blocs périphériques en accord avec le patient pour les interventions des membres qui s'y prêtent.	R

Question 5 — Prise en charge des suites opératoires

5.1 Douleur postopératoire — la maîtrise de la douleur allie anticipation, rigueur de prescription et respect de l'observance.

Recommandation	Force
31. Il est recommandé de mettre en place une stratégie multimodale de la prise en charge de la douleur postopératoire y compris au lieu de résidence : information, prévention, traitement et évaluation.	R
32. Il est souhaitable que les ordonnances d'antalgiques soient remises au patient dès la consultation préopératoire de chirurgie ou d'anesthésie.	S
33. Il est recommandé que les ordonnances d'antalgiques précisent les horaires de prise systématiques et les conditions de recours à un antalgique de niveau plus élevé si nécessaire.	R
34. Il est souhaitable que les modalités de gestion et de prise des analgésiques de « secours » soient expliquées dès la consultation préopératoire.	S
35. Il est souhaitable d'utiliser les infiltrations et les blocs périphériques seuls ou en complément d'une autre technique pour la douleur postopératoire.	S
36. Il est recommandé de formaliser l'organisation du suivi de l'analgésie par cathéters périmerveux au lieu de résidence.	R
37. Il est recommandé de prescrire tout moyen non médicamenteux permettant de réduire la douleur postopératoire (application de froid, posture antalgique...).	R

5.2 Prévention thromboembolique — incidence globalement faible après chirurgie ambulatoire.

Recommandation	Force
38. Il est recommandé de prendre en compte la combinaison du risque individuel du patient et du risque de la chirurgie ; la prévention pharmacologique n'est pas systématique.	R
39. Il est recommandé que la durée du traitement pharmacologique ne soit pas inférieure à cinq jours et soit adaptée au cas par cas ; en risque global faible à modéré, la prophylaxie mécanique par bas de contention est efficace.	R

5.3 Nausées et vomissements postopératoires (NVPO) — pas de stratégie de prévention spécifique à l'ambulatoire ; algorithme usuel selon les facteurs de risque.

Recommandation	Force
40. Il est recommandé d'adopter une stratégie antiémétique prophylactique multimodale chez les patients ambulatoires à haut risque de NVPO.	R
41. Il est souhaitable que le traitement des NVPO survenant après la sortie repose sur des antiémétiques validés en prophylaxie, en changeant de classe et de forme galénique en cas d'échec du premier choix.	S



Question 6 — Modalités de la procédure de sortie

Autoriser la sortie sans concession à la sécurité est le moment-clé de la prise en charge ambulatoire ; les critères évaluent « l'aptitude au retour au lieu de résidence ».

Recommandation	Force
42. Il est recommandé que l'ensemble des modalités de sortie soit formalisé et porté à la connaissance des patients, dans la charte de fonctionnement de l'unité ambulatoire.	R
43. Il est recommandé en l'absence imprévue d'accompagnant de rechercher une alternative avant de proposer un transfert en hospitalisation conventionnelle ; en cas de refus du patient, avoir formalisé une procédure de « sortie contraire à la pratique de l'ambulatoire ».	R
44. Il est souhaitable d'utiliser un score pour autoriser la sortie, facile à mettre en œuvre — pas d'intérêt à utiliser des tests psychomoteurs.	S
45. Il n'est pas recommandé d'imposer une réalimentation liquide et solide avant la sortie.	N
46. Il est possible, après anesthésie générale ou bloc périphérique, de ne pas exiger une miction pour autoriser la sortie, en l'absence de facteur de risque lié au patient ou au type de chirurgie.	P
47. Il est possible, après une rachianesthésie, de ne pas attendre une miction pour autoriser la sortie, sous réserve d'une estimation (clinique, au mieux échographique) du volume vésical résiduel et de l'absence de facteur de risque.	P
48. Il est possible, lorsque des blocs périphériques sont utilisés, de permettre la sortie malgré l'absence de levée du bloc, sous réserve de mesures de protection du membre endormi, d'une information précise et d'une assistance à domicile.	P
49. Il est recommandé, après un bloc périmédullaire, de s'assurer des capacités de déambulation du patient avant la sortie ; le port d'attelle ou de béquille peut être utilisé.	R

Question 7 — Coordination entre les acteurs et continuité des soins

Recommandation	Force
50. Il est recommandé que l'organisation mise en place permette le partage de l'information entre les acteurs de la structure et la coordination des soins avec la médecine de ville.	R
51. Il est recommandé que soient remis au patient, à sa sortie, les documents nécessaires à la continuité des soins.	R
52. Il est recommandé que les acteurs de la structure s'assurent que le processus du retour au lieu de résidence du patient est organisé.	R
53. Il est recommandé que les acteurs de la structure, en collaboration avec la médecine de ville, organisent le suivi du patient après sa sortie en fonction de la prévisibilité des suites et des antécédents du patient.	R

Question 8 — Évaluation et gestion des risques en ambulatoire

Recommandation	Force
54. Il est recommandé de mettre en place une démarche qualité au sein de l'unité ambulatoire : description du processus, analyse des points critiques, plan d'amélioration.	R
55. Il est recommandé que l'organisation de la structure prenne en compte le risque propre au statut d'acteur direct du patient, en particulier dans les phases d'éligibilité, de sortie et de suivi à domicile.	R
56. Il est recommandé de mettre en place une démarche d'analyse et de maîtrise des risques de l'activité ambulatoire et de son évolution dans le temps.	R
57. Il est souhaitable de définir des indicateurs d'analyse et de pilotage adaptés à la structure (qualité des soins, satisfaction, suivi des actes, données médicoéconomiques).	S
58. Il est recommandé d'assurer le suivi de la qualité des soins et de la satisfaction des patients après leur sortie.	R



Question 9 — Spécificités liées à l'âge

9.1 Pédiatrie

Recommandation	Force
59. Il est recommandé que seuls les acteurs d'une même structure définissent entre eux la liste des actes ambulatoires pédiatriques adaptés ; décision médicale prise en colloque singulier avec les parents.	R
60. Il est recommandé que les enfants de score ASA I, II et ASA III équilibré soient éligibles : nés à terme, patients de plus de 3 mois (moins de 3 mois possibles selon l'expérience de l'équipe) ; nés prématurés, âge post-conceptionnel ≥60 semaines (jusqu'à 1 an possible selon l'expérience de l'équipe), <60 semaines = facteur d'exclusion.	R
61. Il est recommandé que l'information délivrée soit adaptée, personnalisée et compréhensible pour les parents et pour l'enfant, incluant le risque possible de report de l'intervention.	R
62. Il est recommandé d'informer les parents de la présence nécessaire d'un accompagnant non conducteur ; au-delà de 10 ans, un second accompagnant n'est plus nécessaire.	R

9.2 Gériatrie — le grand âge n'est pas une contre-indication en soi ; l'ambulatoire semble diminuer l'incidence des troubles du comportement postopératoire par rapport à une hospitalisation conventionnelle.

Recommandation	Force
63. Il est recommandé de faire bénéficier les personnes âgées d'une prise en charge ambulatoire selon l'analyse du bénéfice/risque, la prévisibilité de la prise en charge et l'organisation mise en place.	R
64. Il est recommandé d'éviter les benzodiazépines en préopératoire — elles augmentent l'incidence des troubles du comportement postopératoire.	R

Question 10 — Spécificités organisationnelles et spatiales

Le parcours du patient est au centre de l'organisation de la structure ambulatoire ; il n'y a pas de modèle architectural unique de structure ambulatoire.

Recommandation	Force
65. Il est recommandé que le parcours du patient soit fluide et maîtrisé, relevant d'une pensée logistique agencée avec l'équipe qui prendra en charge le fonctionnement de l'unité.	R
66. Il est recommandé de mettre en place une organisation qui permette une optimisation des flux, garante de la prise en charge des patients dans les délais prévus.	R
67. Il est recommandé que l'unité ambulatoire maîtrise sa propre organisation en ordonnant, contrôlant et dirigeant tous les flux (patients, informations, personnels, matériels).	R

Question 11 — Responsabilité de l'anesthésiste-réanimateur

La responsabilité de l'anesthésiste-réanimateur n'est pas différente de ce qu'elle est en hospitalisation conventionnelle. L'accompagnant est un tiers sans statut particulier (aucune responsabilité juridique spécifique hors mineur/incapable majeur) ; sa signature n'a pas lieu d'être.

Recommandation	Force
68. Il est recommandé de remettre au patient un document écrit concernant les consignes de l'ambulatoire et d'archiver ce document dans le dossier du patient.	R
69. Il est recommandé de vérifier le respect des consignes et d'assurer la traçabilité dans le dossier du patient.	R
70. Il est recommandé d'écrire clairement les modalités d'autorisation de sortie du patient au sein de la charte de fonctionnement de la structure.	R
71. Il est recommandé que l'organisation prévoie qu'un anesthésiste-réanimateur puisse être joint en cas de survenue d'un événement imprévu en rapport avec l'anesthésie, dans les suites immédiates et après la sortie du patient.	R

Sources et traçabilité



Document source : « Prise en charge anesthésique des patients en hospitalisation ambulatoire » — Recommandations Formalisées d'Experts (RFE), Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR). Président du comité d'organisation : Dr Laurent Jouffroy. Coordonnateur du groupe de travail : Dr Anne Guidat (CHRU de Lille). Secrétaire de séance : Dr Bernard Coustets. Groupe de travail : J. Bataille, J. Bientz, C. Bléry, G. Bontemps, J.-F. Cerfon, M.-L. Cittanova, N. Dufeu, L. Delaunay, P. Diemunsch, C. Gatecel, M. Gentili, H. Le Hetet, M. Maillet, S. Nguyen Roux, L. Pain, P. Pérucho, B. Plaud, M. Raucoules-Aime, M. Samama, F. Venutolo.

Version : Ann Fr Anesth Réanim 29 (2010) 67-72. doi:10.1016/j.annfar.2009.12.008.

Méthodologie : aucune grille de cotation scientifique imprimée — force déduite du verbe modal introduisant chaque recommandation (convention bespoke, voir détail en page 1).

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_AFAR_Prise-en-charge-anesthesique-des-patients-en-hospitalisation-ambulatoire.pdf

Couverture : intégralité des 71 recommandations (11 questions), avec le contexte minimal nécessaire à leur compréhension. Argumentaire scientifique détaillé volontairement non transcrit au-delà de ce que porte déjà l'énoncé de chaque recommandation — se référer au texte intégral.

Avertissement — document de 2009/2010 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des 71 recommandations du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Les pratiques organisationnelles et les seuils cités ayant pu évoluer depuis 2009, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.